【临床康复】

电针联合语言康复训练治疗卒中后言语障碍患者的效果

张　平，杨　朴，陈国强，常永乾，孙国权，宋玉佩
（南阳市第一人民医院康复医学科，河南　南阳　473000）

【摘要】 **目的：**观察电针联合语言康复训练治疗卒中后言语障碍患者的效果。**方法：**选取 2021 年 10 月至 2022 年 10 月该院收治的 98 例卒中后言语障碍患者进行前瞻性研究，按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各 49 例。对照组实施语言康复训练，观察组在对照组基础上联合电针治疗，比较两组治疗前后言语功能 [波士顿诊断性失语症检查量表（BDAE）] 评分、负性情绪 [汉密尔顿焦虑量表（HAMA）、汉密尔顿抑郁量表（HAMD）] 评分及生命质量 [生活质量综合评定问卷 –74（GQOLI–74）] 评分。**结果：**治疗后，两组对话和自发言语、言语表达、听觉理解、书面语理解及书写等各项 BDAE 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；两组 HAMD、HAMA 评分均低于治疗前，且观察组低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；两组认知功能、心理状态、社会功能、躯体功能等各项 GQOLI–74 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论：**电针联合语言康复训练治疗卒中后言语障碍患者，可提高言语功能，改善负性情绪，提高生命质量，效果优于单纯语言康复训练治疗。

【关键词】 电针；语言康复训练；卒中；言语障碍；言语功能；生命质量；负性情绪
doi:　10. 3969 / j. issn. 1672-0369. 2024. 01. 024
中图分类号： R246.6　　**文献标识码：** B　　**文章编号：** 1672–0369（2024）01–0079–03

Effects of electroacupuncture combined with language rehabilitation training on patients with post-stroke speech disorders

ZHANG Ping, YANG Pu, CHEN Guoqiang, CHANG Yongqian, SUN Guoquan, SONG Yupei
(Department of Rehabilitation Medicine of Nanyang First People's Hospital, Nanyang 473000 Henan, China)

【**Abstract**】 **Objective:** To observe effects of electroacupuncture combined with language rehabilitation training on patients with post-stroke speech disorders. **Methods:** A prospective study was conducted on 98 patients with post-stroke speech disorders admitted to this hospital from October 2021 to October 2022. They were divided into control group and observation group according to the random number table method, 49 cases in each group. The control group was treated with language rehabilitation training, while the observation group were treated with electroacupuncture on the basis of the control group. The scores of speech function [Boston diagnostic aphasia scale (BDAE)], the negative emotions [Hamilton anxiety scale (HAMA), Hamilton depression scale (HAMD)], and the quality of life [general quality of life inventory-74 (GQOLI-74)] were compared between the two groups before and after the treatment. **Results:** After the treatment, the BDAE scores of dialogue and spontaneous speech, speech expression, auditory comprehension, written language comprehension and writing in the two groups were higher than those before the treatment, those in the observation group were higher than those in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). The HAMD and HAMA scores of the two groups were lower than those before the treatment, those in the observation group were lower than those in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). Further, the GQOLI-74 scores of cognitive function, psychological state, social function and physical function in the two groups were higher than those before the treatment, those in the observation group were higher than those in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). **Conclusions:** Electroacupuncture combined with language rehabilitation training in the treatment of the patients with post-stroke speech disorder can improve the speech function, improve the negative emotions and improve the quality of life. Moreover, it is superior to single language rehabilitation training.

【**Keywords**】Electroacupuncture; Language rehabilitation training; Stroke; Speech disorder; Speech function; Quality of life; Negative emotion

卒中后患者会伴有不同程度的后遗症，其中言语障碍是常见后遗症之一，患者表现为发音障碍、语言表达费力且不流利、阅读能力受损等症状，严重损害患者的沟通能力，降低其生命质量 [1]。中医学将卒中后言语障碍归属于“语涩”“不语”范畴，由风、火、痰、瘀阻滞心肾之经络，阻闭舌窍，致机窍失灵，咽喉失用 [2]。针刺是基于中医基础理论指导下的中医外治之法，可激发人体经气，通畅局部气血，电针刺激是在针刺基础上施加电流，持续刺激局部穴位，从而发挥益气活血、疏通经络等作用。本文观察电针联合语言康复训练治疗卒中后言语障碍患者的效果。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取 2021 年 10 月至 2022 年 10 月本院收治的 98 例卒中后言语障碍患者进行前瞻性

收稿日期：2023–09–07
作者简介：张平（1990.11—），女，汉族，河南南阳人，本科，主管技师，研究方向为卒中后康复治疗。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

研究。纳入标准：符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2014》中卒中的诊断标准[3]；伴有言语障碍。排除标准：其他疾病导致的言语障碍；合并肝、肾及造血系统疾病；合并认知及沟通障碍。患者及家属对本研究内容了解并自愿签署知情同意书，且研究经本院伦理委员会批准。按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各 49 例。对照组男 28 例，女 21 例；年龄 45~72 岁，平均（58.59 ± 3.26）岁；病程 1~4 个月，平均（2.56 ± 0.59）个月；波士顿诊断性失语症检查量表（BDAE）[4]分级：0 级 14 例，1 级 22 例，2 级 13 例。观察组男 27 例，女 22 例；年龄 45~72 岁，平均（58.56 ± 3.24）岁；病程 1~4 个月，平均（2.53 ± 0.56）个月；BDAE 分级：0 级 16 例，1 级 21 例，2 级 12 例。两组一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05），有可比性。

1.2　方法　对照组给予语言康复训练。（1）构音肌训练。包括双唇、舌及软腭运动训练，可辅助冰块刺激。（2）发音训练。由发元音开始，如“a、e、i、o”等，再发出辅音，如“b、p、m、f”等，待患者能完整发出辅音后，将已掌握的辅音和元音结合，发出“pa、ba、ma”等音节。（3）命名训练。将图片放于患者面前，让患者逐一命名，若患者不能说出名字，可予以听觉、视觉刺激进行提示。（4）书写训练。依据患者书写水平，由简单的抄写训练开始，再进行描写训练。（5）简单的单词和句子训练。让患者说一段话，让其他患者进行评议，分辨出错音。（6）阅读训练。将卡片放于患者面前，按照单词、短句、长句的顺序训练阅读。（7）通过写日记和讲故事方法训练患者逻辑思维和文字表达能力，最后由康复师进行纠正。40 min/ 次，5 次 / 周。

观察组在对照组基础上联合电针治疗。选取百会、内关、廉泉、承浆、玉液、金津、三阴交等穴位，常规消毒上述穴位，采用 0.3 mm × 40 mm 毫针，与皮肤呈 30° 进针，进针深度以患者感到局部有酸、麻、胀为宜，针刺完成后连接电针治疗仪，调节频率为 50 Hz，电流为 2 mA，以患者耐受为宜，留针 30 min，30 min/ 次，5 次 / 周。

两组均持续治疗 20 d。

1.3　观察指标　（1）比较两组治疗前后言语功能评分。采用 BDAE 评估，包括对话和自发言语（60 分）、听觉理解（80 分）、言语表达（40 分）、书面语理解（50 分）、书写（40 分），共 5 个维度，27 个条目，得分越高，言语功能越好。（2）比较两组治疗前后负性情绪评分。采用汉密尔顿焦虑量表（HAMA）[5]和汉密尔顿抑郁量表（HAMD）[6]评估患者焦虑和抑郁程度，得分越低，焦虑、抑郁程度越轻。（3）比较两组治疗前后生命质量评分。采用生活质量综合评定问卷 –74（GQOLI–74）[7]评估，内容包括社会功能、认知功能、躯体功能及心理状态，共 4 个维度，每个维度均为 100 分，得分越高，生命质量越好。

1.4　统计学方法　应用 SPSS 22.0 软件进行统计学分析，计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，采用 t 检验，以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组治疗前后言语功能评分比较　治疗前，两组对话和自发言语、言语表达、听觉理解、书面语理解及书写等各项 BDAE 评分比较，差异均无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组对话和自发言语、言语表达、听觉理解、书面语理解及书写等各项 BDAE 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 1。

2.2　两组治疗前后负性情绪评分比较　治疗前，两组 HAMD、HAMA 评分比较，差异均无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组 HAMD、HAMA 评分均低于治疗前，且观察组低于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 2。

2.3　两组治疗前后生命质量评分比较　治疗前，两组认知功能、心理状态、社会功能、躯体功能等各项 GQOLI–74 评分比较，差异均无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组认知功能、心理状态、社会功能、躯体功能等各项 GQOLI–74 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 3。

3　讨论

卒中后言语障碍严重影响患者日常生活和身心健康，临床常采取言语康复训练，一定程度上能够恢复患者语言功能，但单纯采用康复训练见效较慢，且多数患者难以坚持，康复效果一般[8]。

电针刺激是在中医传统针刺理论基础上，结合现代医学中物理、生理等相关知识，对特定穴位进行相应刺激，起到调节脏腑精气、运行气血的目的。本研究结果显示，观察组对话和自发言语、言语表达、听觉理解、书面语理解及书写等各项 BDAE 评分和认知功能、心理状态、社会功能、躯体功

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1　两组治疗前后言语功能评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	对话和自发言语		言语表达		听觉理解		书面语理解		书写	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组（n=49）	15.92 ± 2.05	20.83 ± 2.14*	11.18 ± 1.98	15.36 ± 2.09*	30.39 ± 3.72	49.95 ± 4.14*	15.86 ± 2.10	18.95 ± 2.25*	12.27 ± 2.34	15.56 ± 2.30*
观察组（n=49）	15.96 ± 2.08	26.67 ± 2.19*	11.23 ± 2.03	19.97 ± 2.15*	30.43 ± 3.75	58.76 ± 4.23*	15.92 ± 2.13	27.86 ± 2.34*	12.31 ± 2.45	20.89 ± 2.43*
t 值	0.096	13.351	0.123	10.762	0.053	10.419	0.140	19.213	0.083	11.151
P 值	0.462	0.000	0.451	0.000	0.479	0.000	0.444	0.000	0.467	0.000

注：与治疗前比较，*P<0.05

表 2　两组治疗前后负性情绪评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	HAMD 评分		HAMA 评分	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组（n=49）	18.75 ± 2.10	15.46 ± 1.96*	19.68 ± 2.13	16.52 ± 2.09*
观察组（n=49）	18.71 ± 2.08	11.42 ± 1.78*	19.65 ± 2.11	12.37 ± 2.04*
t 值	0.095	10.681	0.070	9.947
P 值	0.462	0.000	0.472	0.000

注：与治疗前比较，*P<0.05

表 3　两组治疗前后生命质量评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	认知功能		心理状态		社会功能		躯体功能	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组（n=49）	56.42 ± 3.28	68.87 ± 3.52*	59.43 ± 3.24	69.29 ± 3.67*	59.39 ± 4.58	73.45 ± 4.48*	63.20 ± 3.53	72.46 ± 4.20*
观察组（n=49）	56.73 ± 3.32	79.84 ± 3.60*	59.29 ± 3.28	78.81 ± 3.73*	59.43 ± 4.63	81.56 ± 4.62*	63.27 ± 3.67	81.49 ± 4.37*
t 值	0.465	15.252	0.213	12.735	0.043	8.822	0.096	10.429
P 值	0.322	0.000	0.416	0.000	0.483	0.000	0.562	0.000

注：与治疗前比较，*P<0.05

能等各项 GQOLI-74 评分均高于对照组，HAMD、HAMA 评分均低于对照组，这一结果与文献报道相似[9]。分析原因为针刺百会可开窍醒神、清头散风、回阳固脱；针刺内关可宁心安神；针刺廉泉可疏风清热、清咽利喉；针刺承浆可清热解毒、祛风通络、开窍醒神；针刺玉液可消肿解毒、清热利咽；针刺金津可清心降逆、清热消肿；针刺三阴交可调经止带、健脾化湿；诸穴合用可疏通督脉、调理心神。加之电刺激可对穴位产生直接的、足够深度的刺激，能够改善患者语言中枢功能，促进言语功能恢复。联合语言康复训练可协同刺激基底核语言中枢，进一步改善患者言语功能，提高其语言交流能力，促进患者生命质量提升。

综上所述，电针联合语言康复训练治疗卒中后言语障碍患者，可提高言语功能，改善负性情绪，提高生命质量，效果优于单纯语言康复训练治疗。

参考文献

[1] 李青，刘丽爽，霍娟娟，等 . 经颅磁刺激联合言语听觉反馈训练对脑卒中患者认知功能康复效果的影响 [J]. 中国临床保健杂志，2020，23（5）：660-664.

[2] 董秀娟，覃亮，樊晓瑞，等 . 微针介入结合康复训练对脑卒中后失语症患者语言功能的影响 [J]. 辽宁中医杂志，2020，47（7）：153-156.

[3] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组 . 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2014[J]. 中华神经科杂志，2015，48（4）：246-257.

[4] 李雪青，石志敏 . 脑卒中后失语症神经语言学评测量表述评及其中医量表建立的思路探讨 [J]. 广州中医药大学学报，2016（1）：153-156.

[5] 曲姗，胜利 . 广泛性焦虑量表在综合医院心理科门诊筛查广泛性焦虑障碍的诊断试验 [J]. 中国心理卫生杂志，2015，29（12）：939-944.

[6] 胡旭强，钱敏才，林敏，等 . 斯奈思 – 汉密尔顿快感量表中文版测评抑郁症患者的效度和信度 [J]. 中国心理卫生杂志，2017，31（8）：625-629.

[7] 陈瑜 . 老年人生活质量问卷中文修订版的信效度研究 [J]. 护理研究，2016，30（25）：3120-3122.

[8] 詹杰，洪逸铭，谭峰，等 . 电针联合康复训练对急性缺血性脑卒中患者神经功能的影响 [J]. 辽宁中医杂志，2021，48（2）：172-175.

[9] 何淼红，徐吉芬，刘志成，等 . 电针头针对颅脑损伤后失语症患者言语功能及神经递质的影响 [J]. 现代中西医结合杂志，2021，30（19）：2119-2122.

编辑：原紫一

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net